

Umfrage zur Bachelorarbeit "Talking Medicine"

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Studie zu meiner Bachelorarbeit. Ich versuche, medizinische Informationen für verschiedene Patientenprofile verständlicher zu machen. Dafür nutze ich Künstliche Intelligenz (KI). Das Ziel ist, dass Patienten selbstständig informierte Entscheidungen über ihre Gesundheit treffen können. Das Vorgehen können Sie sich folgendermassen vorstellen:

- Ein medizinischer Text wird eingelesen und das Profil des Patienten wird festgehalten.
- Ein KI-Sprachmodell vereinfacht den Text. Dafür werden dem KI-Modell Anweisungen mitgegeben, entsprechend dem Patientenprofil. Dabei wird auf spezielle Bedürfnisse dieser Gruppe eingegangen. Momentan habe ich folgende Patientenprofile abgebildet:
 - Leien
 - Ältere Menschen
 - Fremdsprachige
 - Menschen mit kognitiven Einschränkungen
 - Menschen mit tiefem Bildungsniveau

- Der entstehende Text sollte alle relevanten medizinischen Informationen beibehalten. Dennoch kann sich der neue Text in Sachen Format, Sprache und Komplexität massiv vom Originaltext unterscheiden. Das hängt zu grossen Teilen auch vom Ausgangstext ab.

Dieser Teil der Studie richtet sich an medizinisches Personal. Durch Ihre Teilnahme an dieser Umfrage möchte ich folgende Frage angehen:

- Gehen durch die Vereinfachung der KI wichtige medizinische Informationen verloren?
- Werden zusätzliche Informationen "erfunden" bzw. dazugeneriert?
- Löst die Vereinfachung gängige Problemmuster beim Verständnis medizinischer Informationen, die Sie bei Ihren Patienten beobachten?
- Würde Ihnen eine automatische Textsimplifizierung dabei helfen, dem Patienten medizinische Informationen besser erklären zu können?

Die Umfrage ist anonym und wird nur im Rahmen meiner Bachelorarbeit ausgewertet.

Ablauf

Auf der Nachfolgenden Seite werden Sie zwei Texte antreffen.

- Der erste Text stellt einen fiktiven Notfallbericht dar, der in einem gängigen Format des Spitals Walenstadt verfasst wurde.
- Der zweite Text ist eine KI-generierte Vereinfachung des ersten Texts. Der Text wurde spezifisch für das Patientenprofil "ältere Menschen" vereinfacht.

Lesen Sie die Texte aufmerksam. Achten Sie beim zweiten Text speziell darauf, ob es inhaltliche Unterschiede zum Originaltext gibt. Beantworten Sie dann die entsprechenden Fragen.

Text 1: Original

Ärztezentrum

Ärztliche Leitung

Gesundheitsstrasse

8882 Unterterzen

Walenstadt,
02.05.2026 / ABCDEF

**provisorischer
Notfallbericht**

MUSTERMANN Michael,
01.01.1998, Blüemliweg 3 8882 Unterterzen

Tel. 079 100 00 00

Fallnr: 12345678

Wir berichten
über die ambulante Konsultation auf der Zentralen Notfallstation vom 18.07.2024.

Diagnose: (Diagnosecode: S82.28)

St.n.
Verkehrsunfall

Tibiakontusion
rechts

Ausschluss

- Blutung

-
Pneumo-/Hämatothorax

**Jetziges
Leiden:**

Notfallmässige
Vorstellung nach Verkehrsunfall. Der Patient berichtet, dass ein anderes
Fahrzeug mit ca. 60 km/h von der rechten Seite kommend in sein Auto
gefahren sei. Hierbei kam es zu einem Schleudertrauma und der seitliche Airbag
habe ausgelöst.

Pers. Anamnese: Vorerkrankungen: Status nach
Patch-Plastik bei Septumdefekt

Status:

Schädel o.B.

Viszerokranium unauffällig. HWS frei.

Neurologie: GCS

15, voll orientiert, Pupillen isokor und bds. sowie konsensuell prompt auf Licht reagibel, Okkulomotorik regelrecht. Sprache unauffällig. Kein Meningismus. Hirnnerven grobkursorisch unauffällig. Sensibilität der oberen und unteren Extremität seitengleich intakt. Rohe Kraft an oberer und unterer Extremität allseits M5. Muskeltonus normal. BSR, TSR, PSR, ASR symmetrisch auslösbar. Koordination (FNV, KHV, Vorhalteversuch, Diadochokinese) normal. Gleichgewicht (Unterberger, Rhomberg) intakt. Bewegungsapparat: grobkursorische Prüfung altersentsprechend.

Schultern und

Klavikula bland (Druckdolenz über dem Caput humeri links). Ellbogen und Handgelenke bds. unauffällig und frei beweglich.

BWS frei. LWS

indolent. Paravertebraler Hartspann cervical. Thorax stabil.

Herz/Kreislauf:

Normale Herztöne, kein Geräusch, Halsvenen nicht gestaut, periphere Pulse allseits palpabel, keine Beinödeme.

Lunge:

Symmetrische Atmung, vesikuläres Atemgeräusch über allen Lungenfeldern, keine Rasselgeräusche. Abdomen: weich, normale Darmgeräusche. Kein Rüttelschmerz, indolent, kein Loslassschmerz, Milz nicht palpabel. Nierenlogen frei. Becken stabil.

Hüften und Knie

bds. frei beweglich, voll belastbar. OSG und Fuss beidseits ohne Befund. Hämatom am linken Unterschenkel, Druckdolenz.

Druckmarke vom
Sicherheitsgurt links

Untersuchungen:

- Urin: Keine
Erythrozyturie

- EKG: Normofrequenter
Sinusrhythmus mit einer Frequenz von 73/min, Indifferenzlagetyp, inverse
P-Welle in III, keine AV-Blockierung, keine Schenkelblock Klärung,
ST-Streckensenkung in I, verzögerter R-Progress, RS-Umschlag zwischen V2 und
V3, über Spitzen T-Wellen in V2 und V3, keine S-Persistenz

- Röntgen
Schulter links: Keine Fraktur. Keine Luxation. In den miterfassten
Lungenabschnitten kein H. a. einen Pneumothorax.

- Röntgen
Unterschenkel rechts: Keine Fraktur oder Luxation der Unterschenkelknochen rechts.

- eFAST: Kein
Pneumothorax, keine freie Flüssigkeit in den grossen Körperhöhlen, kein
Perikarderguss

Beurteilung:

Insgesamt
zeigten sich geringe Traumafolgen. Der Patient konnte in die Häuslichkeit
entlassen werden.

Prozedere:

Bedarfsgerechte
Analgesie mit bspw. Metamizol und Ibuprofen.

Bei Dyspnoe

oder Thoraxschmerzen ist eine Wiedervorstellung auf der Notfallstation vereinbart worden.

Freundliche
Grüsse

Dr.
med. Muster Max

Oberarzt

dixit

Dipl.
med. Meier Mike
Assistenzarzt

Text 2: Vereinfachung

Bericht über den Notfallbesuch am 16.09.2025

Diagnose:

- Verletzung nach einem
Verkehrsunfall

- Prellung des rechten
Schienbeins (Tibia)

- Kein Hinweis auf innere
Blutungen oder Luftansammlungen in der Lunge (Pneumothorax) oder
Blutansammlungen im Brustkorb (Hämatothorax)

Unfallhergang:

Der Patient war in einen Autounfall verwickelt. Ein anderes Fahrzeug fuhr mit etwa 60 km/h von rechts in sein Auto. Dabei kam es zu einem Schleudertrauma. Der seitliche Airbag wurde ausgelöst.

Vorerkrankungen:

- Operation am Herzen wegen eines Lochs in der Herzscheidewand (Septumdefekt)

Untersuchungsergebnisse:

- **Kopf:** Keine Auffälligkeiten am Schädel oder Gesicht. Die Halswirbelsäule ist frei beweglich.

- Nerven und Gehirn:

Der Patient war wach, orientiert und ansprechbar. Die Pupillen reagierten normal auf Licht. Die Augenbewegungen und die Sprache waren unauffällig. Die Nerven und Muskeln funktionierten normal. Keine Anzeichen für eine Nackensteifigkeit.

- Bewegungsapparat:

Keine Auffälligkeiten an Schultern, Ellbogen, Händen, Wirbelsäule, Hüften, Knien und Füßen. Am linken Oberarm schmerzt der Bereich des Schulterkopfes bei Druck. Am linken Unterschenkel gibt es einen blauen Fleck (Hämatom) und eine Druckempfindlichkeit. Eine Druckspur vom Sicherheitsgurt ist sichtbar.

- Herz und Kreislauf:

Herzschlag und Blutdruck sind normal. Die Halsvenen sind nicht gestaut. Alle wichtigen Arterien sind gut tastbar. Es gibt keine Schwellungen an den Beinen.

- Lunge: Die Atmung

ist gleichmäßig. Es gibt keine auffälligen Atemgeräusche.

- Bauch: Der Bauch ist

weich. Es gibt keine Schmerzen bei Druck. Die Organe wie Milz und Nieren sind nicht vergrößert.

- Becken: Stabil und ohne Auffälligkeiten.

Zusätzliche Untersuchungen:

- Urin: Kein Blut im Urin.

- EKG (Herzuntersuchung):

Der Herzrhythmus ist normal. Es gibt keine schwerwiegenden Auffälligkeiten.

- Röntgen Schulter links:

Kein Bruch oder Verrenkung. Auch die Lunge zeigt hier keine Auffälligkeiten.

- Röntgen Unterschenkel

rechts: Kein Bruch oder Verrenkung.

- Ultraschall (eFAST):

Keine Luftansammlungen in der Lunge. Keine freie Flüssigkeit im Brustkorb, Bauchraum oder Herzbeutel.

Beurteilung:

Es gab nur leichte Verletzungen durch den Unfall. Der Patient konnte nach Hause entlassen werden.

Empfehlungen:

- Schmerzmittel wie Metamizol oder Ibuprofen können bei Bedarf eingenommen werden.

- Bei Atemnot oder Schmerzen im Brustbereich soll der Patient sofort wieder zur Notfallstation kommen.

Fehlen in Text 2 relevante medizinische Informationen, die in Text 1 vorhanden sind?

- ☐ Text 2 beinhaltet gravierende Lücken
- ☐ Text 2 beinhaltet grosse Lücken
- ☒ Text 2 beinhaltet vertretbare Lücken
- ☐ Text 2 beinhaltet nur irrelevante Lücken
- ☐ Text 2 beinhaltet keine Lücken

Ich habe folgende (medizinisch relevanten) Lücken gefunden:

Finden Sie in Text 2 zusätzliche Informationen, die in Text 1 nicht vorhanden sind?

- ☐ Text 2 beinhaltet grösstenteils neue Informationen
- ☐ Text 2 beinhaltet viele neue Informationen
- ☐ Text 2 beinhaltet einige neue Informationen
- ☐ Text 2 beinhaltet wenige neue Informationen
- ☒ Text 2 beinhaltet keine neuen Informationen

Ich habe in Text 2 folgende Informationen gefunden, die in Text 1 nicht vorhanden waren:

Sind alle zusätzlich generierten Informationen in Text 2 gerechtfertigt? handelt es sich um keine Falschinformationen?

- ☐ Ja
- ☒ Nein
- ☐ Ich habe keine zusätzlich generierten Informationen gefunden

Text 2 wurde für Leien vereinfacht, speziell für das Patientenprofil "ältere Menschen". Ist Text 2 Ihrer Meinung nach besser Verständlich für ältere Patienten als Text 1?

- ☒ Ja
- ☐ Nein

Begründen Sie Ihre Antwort:

Weniger Fachbegriffe

Welche dieser Aspekte in Text 2 helfen Ihrer Meinung nach der Zielgruppe, die Informationen besser aufnehmen und verstehen zu können? (Mehrere / keine Antwort möglich)

- ☒ Kurze Satzlänge & kurze Wörter
- ☐ Nur eine Information pro Satz
- ☒ Verständliche oder erklärte Fachbegriffe
- ☐ Strukturierter Text (klare Absätze, Gliederung, Stichpunkte etc.)
- ☒ Die Handlungsmöglichkeiten / Handlungsempfehlungen werden klar aufgezeigt
- ☐ Der Text ist exakt formuliert (vermeidet Spekulationen)
- ☐ Sonstiges:

Könnten Sie guten Gewissens einen solchen vereinfachten Text an meinen Patienten abgeben (Auflagen des Arbeitgebers können vernachlässigt werden)?

- ☐ Ja, ohne Kontrolle durch mich
- ☒ Ja, aber nur, wenn ich ihn zuerst kontrollieren kann
- ☐ Nein

Falls Sie die vorherige Frage mit "Nein" beantwortet haben, begründen Sie ihre Entscheidung:

.....

Welches ist ihr höchster Bildungsabschluss? *

- ☐ Obligatorische Schule
- ☐ Fachmann/-frau Gesundheit
- ☐ Andere Berufslehre
- ☐ Maturität
- ☐ Pflegefachmann/-frau HF
- ☒ Abgeschlossenes Medizinstudium
- ☐ Anderer höherer Abschluss
- ☐ Möchte ich nicht nennen
- ☐ Sonstiges:

Meine Arbeit beinhaltet regelmässig aktiven Umgang mit älteren Menschen:

- ☒ Ja
- ☐ eher selten
- ☐ Nein

Ich kläre regelmässig Patienten über medizinische Sachverhalte auf (z.B. erkläre Krankheitsbilder / Therapien oder ärztliche Rezepte):

- ☒ Ja
- ☐ eher selten
- ☐ Nein

Haben Sie noch Anmerkungen zu dieser Umfrage?

Es gibt kleine Fehler in Text 2, die wahrscheinlich für das gesamte Verständnis irrelevant sind, inhaltlich jedoch falsch wären.

Ende der Umfrage
Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt.

Google

Umfrage zur Bachelorarbeit "Talking Medicine"

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Studie zu meiner Bachelorarbeit. Ich versuche, medizinische Informationen für verschiedene Patientenprofile verständlicher zu machen. Dafür nutze ich Künstliche Intelligenz (KI). Das Ziel ist, dass Patienten selbstständig informierte Entscheidungen über ihre Gesundheit treffen können. Das Vorgehen können Sie sich folgendermassen vorstellen:

- Ein medizinischer Text wird eingelesen und das Profil des Patienten wird festgehalten.
- Ein KI-Sprachmodell vereinfacht den Text. Dafür werden dem KI-Modell Anweisungen mitgegeben, entsprechend dem Patientenprofil. Dabei wird auf spezielle Bedürfnisse dieser Gruppe eingegangen. Momentan habe ich folgende Patientenprofile abgebildet:
 - Leien
 - Ältere Menschen
 - Fremdsprachige
 - Menschen mit kognitiven Einschränkungen
 - Menschen mit tiefem Bildungsniveau
- Der entstehende Text sollte alle relevanten medizinischen Informationen beibehalten. Dennoch kann sich der neue Text in Sachen Format,

Sprache und Komplexität massiv vom Originaltext unterscheiden. Das hängt zu grossen Teilen auch vom Ausgangstext ab.

Dieser Teil der Studie richtet sich an medizinisches Personal. Durch Ihre Teilnahme an dieser Umfrage möchte ich folgende Frage angehen:

- Gehen durch die Vereinfachung der KI wichtige medizinische Informationen verloren?
- Werden zusätzliche Informationen "erfunden" bzw. dazugeneriert?
- Löst die Vereinfachung gängige Problemmuster beim Verständnis medizinischer Informationen, die Sie bei Ihren Patienten beobachten?
- Würde Ihnen eine automatische Textsimplifizierung dabei helfen, dem Patienten medizinische Informationen besser erklären zu können?

Die Umfrage ist anonym und wird nur im Rahmen meiner Bachelorarbeit ausgewertet.

Ablauf

Auf der Nachfolgenden Seite werden Sie zwei Texte antreffen.

- Der erste Text stellt einen fiktiven Notfallbericht dar, der in einem gängigen Format des Spitals Walenstadt verfasst wurde.
- Der zweite Text ist eine KI-generierte Vereinfachung des ersten Texts. Der Text wurde spezifisch für das Patientenprofil "ältere Menschen" vereinfacht.

Lesen Sie die Texte aufmerksam. Achten Sie beim zweiten Text speziell darauf, ob es inhaltliche Unterschiede zum Originaltext gibt. Beantworten Sie dann die entsprechenden Fragen.

Text 1: Original

Ärztezentrum

Ärztliche Leitung

Gesundheitsstrasse

8882 Unterterzen

Walenstadt,
02.05.2026 / ABCDEF

**provisorischer
Notfallbericht**

MUSTERMANN Michael,
01.01.1998, Blüemliweg 3 8882 Unterterzen

Tel. 079 100 00 00

Fallnr: 12345678

Wir berichten
über die ambulante Konsultation auf der Zentralen Notfallstation vom 18.07.2024.

Diagnose: (Diagnosecode: S82.28)

St.n.
Verkehrsunfall

Tibiakontusion
rechts

Ausschluss

- Blutung

-
Pneumo-/Hämatothorax

**Jetziges
Leiden:**

Notfallmässige
Vorstellung nach Verkehrsunfall. Der Patient berichtet, dass ein anderes
Fahrzeug mit ca. 60 km/h von der rechten Seite kommend in sein Auto
gefahren sei. Hierbei kam es zu einem Schleudertrauma und der seitliche Airbag
habe ausgelöst.

Pers. Anamnese: Vorerkrankungen: Status nach
Patch-Plastik bei Septumdefekt

Status:

Schädel o.B.

Viszerokranium unauffällig. HWS frei.

Neurologie: GCS

15, voll orientiert, Pupillen isokor und bds. sowie konsensuell prompt auf Licht reagibel, Okkulomotorik regelrecht. Sprache unauffällig. Kein Meningismus. Hirnnerven grobkursorisch unauffällig. Sensibilität der oberen und unteren Extremität seitengleich intakt. Rohe Kraft an oberer und unterer Extremität allseits M5. Muskeltonus normal. BSR, TSR, PSR, ASR symmetrisch auslösbar. Koordination (FNV, KHV, Vorhalteversuch, Diadochokinese) normal. Gleichgewicht (Unterberger, Rhomberg) intakt. Bewegungsapparat: grobkursorische Prüfung altersentsprechend.

Schultern und

Klavikula bland (Druckdolenz über dem Caput humeri links). Ellbogen und Handgelenke bds. unauffällig und frei beweglich.

BWS frei. LWS

indolent. Paravertebraler Hartspann cervical. Thorax stabil.

Herz/Kreislauf:

Normale Herztöne, kein Geräusch, Halsvenen nicht gestaut, periphere Pulse allseits palpabel, keine Beinödeme.

Lunge:

Symmetrische Atmung, vesikuläres Atemgeräusch über allen Lungenfeldern, keine Rasselgeräusche. Abdomen: weich, normale Darmgeräusche. Kein Rüttelschmerz, indolent, kein Loslassschmerz, Milz nicht palpabel. Nierenlogen frei. Becken stabil.

Hüften und Knie

bds. frei beweglich, voll belastbar. OSG und Fuss beidseits ohne Befund. Hämatom am linken Unterschenkel, Druckdolenz.

Druckmarke vom
Sicherheitsgurt links

Untersuchungen:

- Urin: Keine
Erythrozyturie

- EKG: Normofrequenter
Sinusrhythmus mit einer Frequenz von 73/min, Indifferenzlagetyp, inverse
P-Welle in III, keine AV-Blockierung, keine Schenkelblock Klärung,
ST-Streckensenkung in I, verzögerter R-Progress, RS-Umschlag zwischen V2 und
V3, über Spitzen T-Wellen in V2 und V3, keine S-Persistenz

- Röntgen
Schulter links: Keine Fraktur. Keine Luxation. In den miterfassten
Lungenabschnitten kein H. a. einen Pneumothorax.

- Röntgen
Unterschenkel rechts: Keine Fraktur oder Luxation der Unterschenkelknochen rechts.

- eFAST: Kein
Pneumothorax, keine freie Flüssigkeit in den grossen Körperhöhlen, kein
Perikarderguss

Beurteilung:

Insgesamt
zeigten sich geringe Traumafolgen. Der Patient konnte in die Häuslichkeit
entlassen werden.

Prozedere:

Bedarfsgerechte
Analgesie mit bspw. Metamizol und Ibuprofen.

Bei Dyspnoe

oder Thoraxschmerzen ist eine Wiedervorstellung auf der Notfallstation vereinbart worden.

Freundliche
Grüsse

Dr.
med. Muster Max

Oberarzt

dixit

Dipl.
med. Meier Mike
Assistenzarzt

Text 2: Vereinfachung

Bericht über den Notfallbesuch am 16.09.2025

Diagnose:

- Verletzung nach einem
Verkehrsunfall

- Prellung des rechten
Schienbeins (Tibia)

- Kein Hinweis auf innere
Blutungen oder Luftansammlungen in der Lunge (Pneumothorax) oder
Blutansammlungen im Brustkorb (Hämatothorax)

Unfallhergang:

Der Patient war in einen Autounfall verwickelt. Ein anderes Fahrzeug fuhr mit etwa 60 km/h von rechts in sein Auto. Dabei kam es zu einem Schleudertrauma. Der seitliche Airbag wurde ausgelöst.

Vorerkrankungen:

- Operation am Herzen wegen eines Lochs in der Herzscheidewand (Septumdefekt)

Untersuchungsergebnisse:

- **Kopf:** Keine Auffälligkeiten am Schädel oder Gesicht. Die Halswirbelsäule ist frei beweglich.

- Nerven und Gehirn:

Der Patient war wach, orientiert und ansprechbar. Die Pupillen reagierten normal auf Licht. Die Augenbewegungen und die Sprache waren unauffällig. Die Nerven und Muskeln funktionierten normal. Keine Anzeichen für eine Nackensteifigkeit.

- Bewegungsapparat:

Keine Auffälligkeiten an Schultern, Ellbogen, Händen, Wirbelsäule, Hüften, Knien und Füßen. Am linken Oberarm schmerzt der Bereich des Schulterkopfes bei Druck. Am linken Unterschenkel gibt es einen blauen Fleck (Hämatom) und eine Druckempfindlichkeit. Eine Druckspur vom Sicherheitsgurt ist sichtbar.

- Herz und Kreislauf:

Herzschlag und Blutdruck sind normal. Die Halsvenen sind nicht gestaut. Alle wichtigen Arterien sind gut tastbar. Es gibt keine Schwellungen an den Beinen.

- Lunge: Die Atmung

ist gleichmäßig. Es gibt keine auffälligen Atemgeräusche.

- Bauch: Der Bauch ist

weich. Es gibt keine Schmerzen bei Druck. Die Organe wie Milz und Nieren sind nicht vergrößert.

- Becken: Stabil und ohne Auffälligkeiten.

Zusätzliche Untersuchungen:

- Urin: Kein Blut im Urin.

- EKG (Herzuntersuchung):

Der Herzrhythmus ist normal. Es gibt keine schwerwiegenden Auffälligkeiten.

- Röntgen Schulter links:

Kein Bruch oder Verrenkung. Auch die Lunge zeigt hier keine Auffälligkeiten.

- Röntgen Unterschenkel

rechts: Kein Bruch oder Verrenkung.

- Ultraschall (eFAST):

Keine Luftansammlungen in der Lunge. Keine freie Flüssigkeit im Brustkorb, Bauchraum oder Herzbeutel.

Beurteilung:

Es gab nur leichte Verletzungen durch den Unfall. Der Patient konnte nach Hause entlassen werden.

Empfehlungen:

- Schmerzmittel wie Metamizol oder Ibuprofen können bei Bedarf eingenommen werden.

- Bei Atemnot oder Schmerzen im Brustbereich soll der Patient sofort wieder zur Notfallstation kommen.

Fehlen in Text 2 relevante medizinische Informationen, die in Text 1 vorhanden sind?

- ☐ Text 2 beinhaltet gravierende Lücken
- ☐ Text 2 beinhaltet grosse Lücken
- ☐ Text 2 beinhaltet vertretbare Lücken
- ☒ Text 2 beinhaltet nur irrelevante Lücken
- ☐ Text 2 beinhaltet keine Lücken

Ich habe folgende (medizinisch relevanten) Lücken gefunden:

Finden Sie in Text 2 zusätzliche Informationen, die in Text 1 nicht vorhanden sind?

- ☐ Text 2 beinhaltet grösstenteils neue Informationen
- ☐ Text 2 beinhaltet viele neue Informationen
- ☐ Text 2 beinhaltet einige neue Informationen
- ☐ Text 2 beinhaltet wenige neue Informationen
- ☒ Text 2 beinhaltet keine neuen Informationen

Ich habe in Text 2 folgende Informationen gefunden, die in Text 1 nicht vorhanden waren:

Sind alle zusätzlich generierten Informationen in Text 2 gerechtfertigt? handelt es sich um keine Falschinformationen?

- ☐ Ja
- ☐ Nein
- ☒ Ich habe keine zusätzlich generierten Informationen gefunden

Text 2 wurde für Leien vereinfacht, speziell für das Patientenprofil "ältere Menschen". Ist Text 2 Ihrer Meinung nach besser Verständlich für ältere Patienten als Text 1?

- ☒ Ja
- ☐ Nein

Begründen Sie Ihre Antwort:

Weniger medizinische Begriffe

Welche dieser Aspekte in Text 2 helfen Ihrer Meinung nach der Zielgruppe, die Informationen besser aufnehmen und verstehen zu können? (Mehrere / keine Antwort möglich)

- ☒ Kurze Satzlänge & kurze Wörter
- ☒ Nur eine Information pro Satz
- ☐ Verständliche oder erklärte Fachbegriffe
- ☐ Strukturierter Text (klare Absätze, Gliederung, Stichpunkte etc.)
- ☐ Die Handlungsmöglichkeiten / Handlungsempfehlungen werden klar aufgezeigt
- ☐ Der Text ist exakt formuliert (vermeidet Spekulationen)
- ☐ Sonstiges:

Könnten Sie guten Gewissens einen solchen vereinfachten Text an meinen Patienten abgeben (Auflagen des Arbeitgebers können vernachlässigt werden)?

- ☐ Ja, ohne Kontrolle durch mich
- ☒ Ja, aber nur, wenn ich ihn zuerst kontrollieren kann
- ☐ Nein

Falls Sie die vorherige Frage mit "Nein" beantwortet haben, begründen Sie ihre Entscheidung:

.....

Welches ist ihr höchster Bildungsabschluss? *

- ☐ Obligatorische Schule
- ☐ Fachmann/-frau Gesundheit
- ☐ Andere Berufslehre
- ☐ Maturität
- ☐ Pflegefachmann/-frau HF
- ☐ Abgeschlossenes Medizinstudium
- ☒ Anderer höherer Abschluss
- ☐ Möchte ich nicht nennen
- ☐ Sonstiges:

Meine Arbeit beinhaltet regelmässig aktiven Umgang mit älteren Menschen:

- ☒ Ja
- ☐ eher selten
- ☐ Nein

Ich kläre regelmässig Patienten über medizinische Sachverhalte auf (z.B. erkläre Krankheitsbilder / Therapien oder ärztliche Rezepte):

- ☒ Ja
- ☐ eher selten
- ☐ Nein

Haben Sie noch Anmerkungen zu dieser Umfrage?

Ende der Umfrage
Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt.

Google